

내분비계 문제

전문간호사 자격시험 대비 문제집 — 내분비계 (CHAPTER 10).

문항 바로가기

- 문 01
- 문 02
- 문 03
- 문 04
- 문 05
- 문 06
- 문 07
- 문 08
- 문 09
- 문 10
- 문 11
- 문 12
- 문 13
- 문 14
- 문 15
- 문 16
- 문 17
- 문 18
- 문 19-20
- 문 21
- 문 22
- 문 23
- 문 24
- 문 25
- 문 26
- 문 27
- 문 28
- 문 29
- 문 30
- 문 31
- 문 32
- 문 33
- 문 34
- 문 35
- 문 36
- 문 37

문 01 당뇨병 케톤산증(DKA) · ABG

문항

당뇨성 케톤산증(DKA) 환자의 동맥혈가스분석(ABG) 결과가 다음과 같을 때 적절한 간호중재는?

pH 6.8 / PaO₂ 92 mmHg / PCO₂ 35 mmHg / HCO₃ 15 mEq/L

보기

1. 비강캐놀라로 산소 2 L/min를 적용한다.
2. 매 시간마다 간이혈당검사를 시행한다.
3. 생리식염수 200 mL에 중탄산나트륨 100 mEq을 투여한다.
4. 두 시간 후에 ABG를 다시 확인한다.
5. 분당 18회 미만의 과소호흡을 유도한다.

CHAPTER 10

전문간호사 자격시험 대비

내분비계

01 당뇨병 케톤산증(DKA) 환자의 동맥혈가스분석(ABG) 결과가 다음과 같을 때 적절한 간호중재는?

- pH 6.8
- PaO₂ 92 mmHg
- PCO₂ 35 mmHg
- HCO₃ 15 mEq/L

- ① 비강캐놀라로 산소 2 L/min를 적용한다.
- ② 매 시간마다 간이혈당검사를 시행한다.
- ③ 생리식염수 200 mL에 중탄산나트륨 100 mEq을 투여한다.
- ④ 두 시간 후에 ABG를 다시 확인한다.
- ⑤ 분당 18회 미만의 과소호흡을 유도한다.

02 당뇨병 케톤산증 환자의 인슐린 정맥주사를 인슐린 피하주사로 전환할 때 우선적으로 고려해야 하는 것은?

- ① 인슐린 피하주사를 시작한 후 1~2시간 동안 정맥주사 인슐린을 유지한다.
- ② 24시간 동안 30분마다 혈당을 확인한다.
- ③ 인슐린 피하주사를 투여하자마자 인슐린 정맥주입을 중단한다.
- ④ 환자의 경련 징후를 면밀히 모니터한다.
- ⑤ 포도당 용액을 정맥으로 유지한다.

chapter 10 내분비계 | 277

p.179 원문(검사수치 포함)

문 02 DKA · 인슐린 정맥→피하 전환

문항 당뇨병 케톤산증 환자의 인슐린 정맥주사를 인슐린 피하주사로 전환할 때 우선적으로 고려해야 하는 것은?

보기

1. 인슐린 피하주사를 시작한 후 1~2시간 동안 정맥주사 인슐린을 유지한다.
2. 24시간 동안 30분마다 혈당을 확인한다.
3. 인슐린 피하주사를 투여하자마자 인슐린 정맥주입을 중단한다.
4. 환자의 경련 징후를 면밀히 모니터한다.
5. 포도당 용액을 정맥으로 유지한다.

문 03 중증 저혈당 · 의식저하

문항 심한 저혈당으로 의식이 저하되어 반응이 없는 환자에게 적절한 중재는?

보기

1. 물 25 mL에 50 % 포도당 용액을 정맥주사 하고 한 시간 후 재사정한다.
2. 치즈와 크래커를 제공하고 15분 후에 재사정한다.
3. 물 50 mL에 25 % 포도당 용액을 정맥주사하고 30분 후 재사정한다.
4. 젤리 10개를 제공하고 6분 후 재사정한다.
5. 30분간 지켜보다가 재사정한다.

문 04 요붕증(DI) 감별

문항

뇌종양을 진단받고 중환자실에 입원한 30세 여자가 물을 지나치게 많이 섭취하는 것이 관찰되었다. 간호사는 환자의 물병을 6시간 동안 8번이나 채웠으며, 지난 24시간의 섭취량 및 배설량 상에서 환자의 배뇨량은 20L를 초과하였다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 탈수
2. 요붕증(diabetes insipidus)
3. 항이뇨호르몬분비이상증후군(SIADH)
4. 급성 부신기능부전증(acute adrenal insufficiency)
5. 고혈당성고삼투압증후군

문 05 고혈당성고삼투압증후군(HHS) 소견

문항

고혈당성고삼투압증후군(HHS) 환자에서 고혈당 이외에 다음 중 HHS와 관련 있는 결과는?

보기

1. 케톤뇨증 없음
2. 혈청 삼투압 감소
3. 아세톤 호흡
4. 신경학적 변화 없음
5. 소변량 감소

문 06 악성 폐암 · 위험 질환

문항 최근 항암치료를 시작한 악성 폐암 환자에게 현재의 건강 상태와 치료요법으로 인해 나타날 위험이 높은 질환은?

보기

1. 쿠싱증후군(Cushing syndrome)
2. 항이뇨호르몬분비이상증후군(SIADH)
3. 애디슨 병(Addison disease)
4. 갑상선 중독증(thyroid storm)
5. 요붕증(DI)

문 07 SIADH 치료·간호

문항 항이뇨호르몬분비이상증후군(SIADH) 환자의 치료 및 간호로 옳은 것은?

보기

1. 식이섭취량을 면밀히 모니터한다.
2. Democlocycline, lithium, dilantin을 투여한다.
3. 수분 정체를 위해서 저장성 식염수를 주입한다.
4. BUN과 Creatinine 수치를 모니터한다.
5. 바소프레신을 투여한다.

문 08 SIADH · ADH 과다분비 결과

문항 항이뇨호르몬분비이상증후군(SIADH)에서 ADH의 과다 분비로 인해 나타나는 결과는?

보기

1. 저혈량증(hypovolemia)
2. 고혈량증(hypervolemia)
3. 저칼슘혈증(hypocalcemia)
4. 고요산혈증(hyperuricemia)
5. 고나트륨혈증(hyponatremia)

문 09 HHS 징후

문항 고혈당성고삼투압증후군(HHS)이 있는 환자에게 나타나는 징후는?

보기

1. 과다호흡
2. 저체온
3. 말초부종
4. 빈맥
5. 고혈압

문 10 당뇨신장병 검사

문항 당뇨신장병(diabetic nephropathy)을 확인하는 가장 적절한 검사는?

보기

1. 크레아티닌청소율(creatinine clearance)과 사구체여과율(eGFR)
2. 소변의 알부민과 크레아티닌 비율과 사구체여과율
3. 미세알부민뇨(microalbuminuria)
4. 혈청 크레아티닌
5. 혈청 알부민

문 11 갑상선기능 · 검사수치 해석

문항

신경과민과 체중감소를 호소하는 38세 여자의 혈액검사 결과가 다음과 같다. 식이 섭취량이나 운동 수준은 변화가 없다고 한다. 다음 중 가장 의심되는 상태는?

TSH: 0.01 mIU/L (Normal values 0.4–3.8 mIU/L)

Free T4: 6 ng/dL (Normal values 0.8–2.8 ng/dL)

Free T3: 205 ng/dL (Normal values 70–205 ng/dL)

보기

1. 갑상선기능저하증
2. 갑상선기능항진증
3. 무증상 갑상선기능항진증
4. 무증상 갑상선기능저하증
5. 갑상선종독증

p.181 원문(검사수치 포함)

문 12 공복혈당 해석

문항

주 2회 측정한 공복혈당수치가 각각 121 mg/dL, 136 mg/dL인 환자가 이것이 어떤 의미인지 묻는다면 가장 적절한 설명은?

보기

1. 혈당수치가 정상입니다.
2. 1형 당뇨병입니다.
3. 2형 당뇨병입니다.
4. 혈당수치가 비정상적입니다.
5. 진단을 위해 당화혈색소(HbA1C) 검사가 요구됩니다.

문 13 지질·HbA1C 관계

문항

당뇨병이 있는 55세 여자의 공복 지질과 HbA1C 결과가 다음과 같다. 이 환자의 지질수치와 HbA1C의 관계에 대한 설명으로 옳은 것은?

LDL Cholesterol: 120 mg/dL / HDL Cholesterol: 45 mg/dL / Total Cholesterol: 200 mg/dL / Triglycerides: 309 mg/dL / Glycosylated Hemoglobin (HbA1C): 9.2%

보기

1. 특별한 관련이 없다.
2. LDL은 HbA1C가 증가함에 따라 증가할 것이다.
3. HbA1C가 감소됨에 따라 triglycerides가 감소한다.
4. HDL이 증가함에 따라 HbA1C가 감소할 것이다.
5. HbA1C가 증가함에 따라 Total cholesterol이 감소한다.

p.182 원문(검사수치 포함)

문 14 2형 당뇨 조기 진단

문항

2형 당뇨병을 가장 빨리 진단할 수 있는 혈당 이상은?

보기

1. 식후 혈당수치 상승
2. 야간 고혈당
3. 공복혈당 상승
4. 비정상적인 HbA1C 수치
5. 새벽 저혈당

문 15 갑상선기능저하 · levothyroxine

문항

levothyroxine을 복용 중인 45세 갑상선기능저하증 환자의 검사결과가 다음과 같다.
이 때 적절한 중재는?

TSH: 32.7 mIU/L (Normal values: 0.4–3.8 mIU/L)

Free T4: 0.09 ng/dL (Normal values: 0.8–2.8 ng/dL)

Total Cholesterol: 260 mg/dL / LDL Cholesterol: 190 mg/dL / HDL

Cholesterol: 37 mg/dL / Triglyceride: 140 mg/dL

보기

1. 스타틴 치료(statin therapy)를 시작한다.
2. levothyroxine 용량을 조절한다.
3. 식습관 개선을 격려한다.
4. 생활습관 변화를 격려한다.
5. 매일 규칙적으로 혈당을 측정하도록 한다.

p.183 원문(검사수치 포함)

문 16 갑상선 검사수치 진단

문항

환자의 검사 결과가 다음과 같다면 예상되는 진단은?

TSH: 14 mIU/L (정상치: 0.4~3.8 mIU/L)

Free T4: 0.1 ng/dL (정상치: 0.8~2.8 ng/dL)

보기

1. 갑상선기능저하증
2. 갑상선기능항진증
3. 무증상의 갑상선기능항진증
4. 무증상의 갑상선기능저하증
5. 점액수종

p.183 원문(검사수치 포함)

문 17 피로·체중증가 · TSH

문항

45세 여자가 지난 3개월 동안 피로감을 느끼고 체중이 약 4.5 Kg 증가하였다. 이전에는 약 30일 주기로 규칙적으로 생리를 하였으나 지난 3개월 동안에는 30~45일로 다양하였다. 갑상선자극호르몬(TSH) 수치는 13 mIU/L (정상치: 0.4~3.8 mIU/L)이었으며 1주일 후에 재검사 시 15 mIU/L였다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 갑상선기능항진증
2. 갑상선기능저하증
3. 뇌하수체기능저하증
4. 폐경전후증후군
5. 갑상선 중독증

문 18 원발성 갑상선기능저하 선별검사

문항

원발성 갑상선기능저하증을 선별하고 확인하는 데 가장 민감한 검사는?

보기

1. TSH(Thyroid-stimulating hormone)
2. TSH(Thyroid-stimulating hormone), T4
3. TSH(Thyroid-stimulating hormone), T4, T3
4. TSH(Thyroid-stimulating hormone), TRH(thyrotropin-releasing hormone)
5. Troponin

문 19-20 개두술 후 요붕증(공유 지문)

지문

다음 지문을 읽고 질문에 답하시오(문제 19-20).

개두술 환자를 사정한 결과가 다음과 같다.

시간당 소변량 400~500 mL / 혈청 포도당 100 mg/dL / 혈압 100/68 mmHg / 맥박 수 102회/분 / 호흡수 22회/분

문 19

이 환자에게 예상되는 검사 결과는?

1. 혈청 삼투압 265 mOsm/Kg, 혈청 나트륨 151 mEq/L, 요비중 1.030
2. 혈청 삼투압 280 mOsm/Kg, 혈청 나트륨 151 mEq/L, 요비중 1.001
3. 혈청 삼투압 330 mOsm/Kg

문 20

이 환자에게 가장 적절한 정맥주입 수액은?

1. lactated Ringer's
2. 5% dextrose in water
3. Normal saline
4. 10% dextrose in water
5. 3% Saline

p.184 원문(공유 지문·검사수치 포함)

문 21 HHS 검사결과

문항

다음 중 고혈당성고삼투압증후군(HHS) 환자에게 예상되는 검사결과는?

보기

1. pH 7.15
2. 요비중 1.030
3. 혈청 칼륨 6.1 mEq/L
4. 혈청 삼투압 270 mOsm/Kg
5. 혈당 180 mg/dL

문 22 metformin 작용기전

문항 metformin (Glucophage)의 작용 기전은?

보기

1. 인슐린 생산 촉진
2. sulfonylureas 작용과 동일
3. 말초 조직에서 인슐린 작용 증가와 간내 포도당 생성 감소
4. 신장의 포도당 배설 촉진
5. 포도당 신생 억제

문 23 Sulfonylureas 작용기전

문항 Sulfonylureas의 작용 기전은?

보기

1. 인슐린 수용체 활성화의 길항제
2. 인슐린 분비를 증진하는 약물
3. 신장 포도당 배설 촉진제
4. 간내 포도당 생산을 감소시키는 약물
5. 포도당 흡수 억제

문 24 당뇨·고혈압·단백뇨 항고혈압제

문항 당뇨병과 고혈압을 진단받았고, 지속적인 단백뇨가 있는 환자에게 투여할 수 있는 항고혈압제는?

보기

1. furosemide
2. methyldopa
3. fosinopril
4. nifedipine
5. spironolactone

문 25 biguanide(Metformin) 추적검사

문항 biguanide (Metformin)를 사용할 때 주기적으로 검사해야 하는 것은?

보기

1. creatine kinase (CK)
2. alkaline phosphatase (ALP)
3. alanine aminotransferase (ALT)
4. creatinine (Cr)
5. neutrophil

문 26 meglitinide analogues

문항 2형 당뇨병에서 meglitinide analogues는 특히 어떠한 위험을 최소화하는 데 유용한가?

보기

1. 공복 저혈당
2. 야행성 고혈당
3. 식후 고혈당
4. 식후 저혈당
5. 식전 고혈당

문 27 alpha-glucosidase inhibitor 부작용

문항 당뇨병 환자가 복용하는 alpha-glucosidase inhibitor의 가장 흔한 부작용은?

보기

1. 위장 장애
2. 간독성
3. 신장 기능 장애
4. 증상이 있는 저혈당
5. 이명

문 28 위마비증 · 금기 혈당약

문항 2형 당뇨병을 진단받은 75세 남자에게 위마비증이 있을 때 투여할 수 없는 혈당조절 약물은?

보기

1. insulin glargine (Toujeo; Lantus)
2. insulin aspart (NovoLog)
3. glimepiride (Amaryl)
4. liraglutide (Victoza)
5. metformin (Glucophage)

문 29 Metformin 수술 전후 중단 이유

문항 Metformin을 수술 후 48시간까지 중단해야 하는 이유는 다음 중 이 약물이 어떤 위험을 증가시키기 때문인가?

보기

1. 감염
2. 저혈당
3. 간손상
4. 젖산혈증
5. 마취효과 과다

문 30 Graves병 · 방사성 요오드

문항 Graves' disease 치료 시 방사성 요오드를 사용하는 목적은?

보기

1. 고활동성 갑상선 조직 파괴
2. TSH 생성 감소
3. 갑상선 대사율 변경
4. 증가된 갑상선 크기로 인한 고통 완화
5. 갑상선 호르몬 생산 추진

문 31 갑상선기능항진 · 떨림/빈맥 완화

문항 다음 중 갑상선기능항진증 환자의 떨림 및 빈맥의 완화에 효과가 있는 약물은?

보기

1. propranolol
2. diazepam
3. carbamazepine
4. verapamil
5. furosemide

문 32 노인 levothyroxine 주의사항

문항 노인 환자에게 levothyroxine를 사용할 때 주의사항에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 고령자는 levothyroxine 치료를 빨리 시작하는 것이 필요하다.
2. 용량 조정 후 약 2일 정도 TSH를 확인해야 한다.
3. 노인에게는 성인 용량의 75% 이하로 처방한다.
4. TSH는 검출 불가능한 수준으로 억제되어야 한다.
5. 칼슘과 함께 투여해야 한다.

문 33 levothyroxine 과다 부작용

문항 levothyroxine을 과다 사용했을 때 초래될 수 있는 부작용은?

보기

1. 변비
2. 피로감
3. 신부전
4. 골다공증
5. 범혈구감소증

문 34 Addison병 확진 검사

문항 34세 여자가 점진적 심약, 피로감, 식욕부진, 체중감소 등을 호소하며, 손가락·팔꿈치·무릎을 중심으로 과다 색소침착이 있어 Addison's disease가 의심된다. 이 질환의 확진을 위해 필요한 검사는?

보기

1. calcium
2. TSH
3. cortisol
4. folate
5. catecholamine

문 35 이차성 부신기능부전 기관

문항 다음 중 기능장애가 있을 때 이차적 부신기능부전을 초래하는 기관은?

보기

1. 뇌하수체
2. 갑상선
3. 췌장
4. 시상하부
5. 부갑상선

문 36 뇌하수체절제술 후 부신위기

문항 뇌하수체절제술(hypophysectomy)을 받은 43세 남자가 저혈압, 심한 오심과 구토가 있으며, 청색증과 함께 혼동 증상을 보인다. 이 환자에게 투여할 가장 적절한 약물은?

보기

1. epinephrine
2. insulin
3. adrenaline
4. hydrocortisone
5. glucose

문 37 쿠싱증후군 · 우선 중재

문항 56세 여자가 과거 2년 동안 류마티스 관절염 치료를 위해 경구 스테로이드제를 복용했으며, 현재 쿠싱증후군이 의심된다. 이 환자에게 우선적인 중재는?

보기

1. 스테로이드제 사용을 점차적으로 줄인다.
2. 수술을 의뢰한다.
3. 방사선 치료를 고려한다.
4. mifepristone을 처방한다.
5. 이뇨제를 투여한다.

본 노트는 PDF를 300dpi로 렌더링 후 한국어 OCR(EasyOCR)로 추출한 텍스트를 의학용어 기준으로 교정·재구성한 자료입니다. OCR 특성상 일부 수치·표기에 오차가 있을 수 있으니 원문과 교차 확인하세요. 페이지 스캔 이미지는 각 항목의 [원문] 링크/그림에서 확인할 수 있습니다.